

Paciente: Cecília Maria Albergaria Silva
Data Nasc: 30/06/2020
Solicitante: Dra Silvana Ferreira Kohnert

Pedido: 5912787
Idade: 4 anos e 6 meses
Entrada: 19/01/2025

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO

Técnica:

Os cortes tomográficos computadorizados foram obtidos no plano axial, sem a infusão intravenosa do agente de contraste iodado hidrossolúvel não iônico.

Relatório:

Orifício de trepanação parietal à direita para a entrada de cateter de derivação cuja extremidade distal não aparenta estar totalmente inserida no sistema ventricular. A critério e na ausência de contra-indicações, complementar avaliação com estudo crânio-encefálico por ressonância magnética para uma melhor análise.

Seio esfenoidal direito preenchido por material hipodenso, de provável origem infecciosa / inflamatória.

Discreto espessamento do revestimento mucoso das células etmoidais.

Aumento das partes moles póstero-superiores da rinofaringe, com importante redução da coluna aérea do cavum.

Não há evidência de processo neoplásico intracraniano, hemorragia intraparenquimatosa aguda, isquemia aguda / subaguda, coleções líquidas extra-axiais acima ou abaixo do tentório, desvio das estruturas centromedianas ou apagamento das cisternas da base.

Impressão:

Orifício de trepanação parietal à direita para a entrada de cateter de derivação cuja extremidade distal não aparenta estar totalmente inserida no sistema ventricular. A critério e na ausência de contra-indicações, complementar avaliação com estudo crânio-encefálico por ressonância magnética para uma melhor análise.

Seio esfenoidal direito preenchido por material hipodenso, de provável origem infecciosa / inflamatória.

Discreto espessamento do revestimento mucoso das células etmoidais.

Aumento das partes moles póstero-superiores da rinofaringe, com importante redução da coluna aérea do cavum.



Acesse seu laudo online:
URL: <https://laudo.vx.med.br>
Exame: 2118347
Nascimento: 30/06/2020